

24장. 증후

제 1절 발열

1. 개요

- 발열이란 체온이 정상보다 높은 상태를 의미하는 것으로 소아과 임상에서 가장 많이 볼 수 있는 증상의 하나이다.
- 소아의 양유여 음부족한 생리, 병리적인 증후 때문에 다양한 급만성 병증에 발열 증상이 나타난다.
- 발열은 다양한 체온의 상승이 아니라, 감염에 대한 생체의 적극적인 방어반응이며, 인체에 유리하게 작용하여 중성구 이동 증가 및 항균물질 생산 증가, interferon의 항바이러스 및 항종양 활성 증가, T-cell 증식 증가, 철분 감소에 의한 미생물 성장 감소 등의 면역학적 활성화 작용을 하는 것이 알려져있다.
- 반면 발열은 산소소비량, 이산화탄소 발생 및 심박출량을 증가시켜, 심부전, 심한 빈혈, 폐기능 부전 환아에게 부담을 증가시킬 수 있으며 6개월~5세 소아에서는 양성 열성 경련을 유발할 수 있고, 특발성 간질 환자에서는 빈도가 높게 나타난다.
- 열을 내리려고 해열제를 쓰는 것은 병 자체의 경과에 불리한 영향을 줄 수 있고, 열이 내렸다는 것 때문에 안심하게 되어 병의 자연경과를 잘못 판단할 수도 있으므로 해열제는 환아 및 질병의 상황에 따라 적절하게 사용해야 한다.
- 부모에 대한 교육을 통해 열에 대한 공포증을 감소시켜주는 것이 중요하다

측정부위	정상체온범위℃ (평균℃)	발열(℃)
겨드랑이	35.3 ~ 37.3 (36.2)	≥37.4
입	35.5 ~ 37.5 (36.6)	≥37.6
직장	36.6 ~ 37.9 (37.0)	≥38.0
고막	35.7 ~ 37.5 (36.6)	≥37.6

발열 : 체온이 정상보다 높은 상태

열의 고저는 병정과 증후의 판단 근거가 될 수 없음

발열은 감염에 대한 생체의 적극적인 방어반응으로 중등도의 열은 면역학적으로 이로운 점이 많음

2. 한의학적 원인

분류	원인	증상
외감	① 욱음지기	감수풍사(땀O), 감수한사(땀X), 감수서사, 감수습사
	② 역려지기	감염병
내상	① 유식소상	밤에 열, 복부작열, 수족심열, 배가 그득함, 입맛 없음, 깊은 잠X
	② 음양실조	양허발열 : 양쪽 뺨 붉음, 발 차가움, 소변청장, 하리청곡 음허발열 : 조열, 도한, 오심번열. 소아는 원래 음이 항상 부족한데, 온열병이 오래된 경우
	③ 기혈허손	비허기약 → 중기하함 → 발열 내생

3. 서의학적 원인★

1) 소아 급성발열의 흔한 원인

- ① 감염 : 패혈증 | 상기도염, 기관지염, 폐렴 | 위장염 | 요로감염 | 뇌염, 수막염 | 배꼽염, 봉와직염 감염이 대부분의 원인
- ② 높은 환경온도 : 나이가 어릴수록 외부 온도에 영향 多
- ③ 탈수, 고전해질혈증 : 수분 공급만으로 회복됨
- ④ 인공적 : 예방접종(DPT, 홍역생백신, 장티푸스 등), 약물
- ⑤ 출혈의 흡수 : 체강 또는 체내조직의 출혈, 수술 후

2) 오래 계속되는 열의 원인 (1주 이상)

열이 일주일 이상 계속될 때에는 그 원인을 찾으려 노력해야한다.

- ① 감염 : 결핵, 요로감염, 심내막염, 심근염, 장티푸스, 파라티푸스
- ② 결합조직질환 : 류마티스열, 소아기특발성관절염, 전신홍반루푸스, 가와사키병
- ③ 종양질환 : 백혈병, 신경모세포종, Hodgkin병, Ewing 종양, Wilms 종양
- ④ 중추신경계장애 : 두개내출혈, 경련중첩, 뇌성마비 등
- ⑤ 갑상선기능항진증

알레르기 질환

밖으로 나타나지 않는 염증 또는 농양 ; 횡격막 농양, 신주위 농양, 폐농양, 간농양, 뇌농양, 골수염, 관절염, 치조농양, 농흉, 화농성 심낭염, 골반농양

- ⑥ 심인성 발열 : 흥분, 계속적인 긴장상태

3) 발열 환자에게 진찰시 꼭 보아야 할 점

- ① 목 안 : 인두염, herpangina, herpes성 구내염 등을 확인
- ② 귀 : 급성 중이염
- ③ 피부 : 발진성 질환 (홍역, 풍진, 돌반진, 수두, 수족구병, 성홍열 등)
- ④ 소변 : 요로감염 (급성신우염시 소화기 증상을 동반하여 체했다고 진단하기 쉽다)
- ⑤ 대변 : 장염

4. 불명열★

정의	외래 3주 이상, 입원 상태에서 1주의 검사에도 불구하고 원인을 찾기 힘든 38.5도 이상의 발열	
원인	㉠ 감염성 질환	: 장티푸스, 전염성 단핵구증, 진균·기생충·클라미디아·리케차, 심내막염, 간농양, 신우신염, 부비동염, 골반농양
	㉡ 비감염성 질환	: 악성질환, 염증성 장질환, 약물열, 결체조직질환(소아기 특발성 관절염, 전신성 홍반성 낭창, 가와사키병)
예후	소아 불명열의 예후는 좋음 (cf. 성인 불명열은 사망률 높음(25~40%)) 발열이 지속되어 철저한 검사를 하더라도 약 25%에서는 원인을 밝힐 수 없는 경우가 있음	

4. 변증

1) 변증 요점

분류	원인	증상
표리	표증발열	▪ 발열오한, 두신동통, 비색, 해수, 설태박백, 맥부
	리증발열	• 단열무한, 발열유한, 번갈음냉,뇨황변건, 설질홍, 태황, 맥홍삭
허실	실열	• 장열변갈, 복만거안, 심즉신훈섬어, 뇨적변결, 태황, 맥홍삭혹활실
	허열	• 조열도한, 소수, 오심번열, 구인건조, 설홍소태, 맥세삭

2) 발열의 종류

▪ 발열오한 (發熱惡寒)	외감 표증에 多, 사기와 정기의 상쟁(相爭)
2. 한열왕래 (寒熱往來)	사기가 반표반리(半表半裏)에 있어 오한-발열이 교차
3. 일포조열 (日晡潮熱)	장위(腸胃)에 조열(燥熱)이 내결(內結)하여 일포에 열이 조수(潮水)와 같이 일어나는 것
4. 음허조열 (陰虛潮熱)	오후 또는 밤에 발열 오심번열(五心煩熱)이 특징
5. 아열불양 (身熱不揚)	주로 오후에 발열 열이 심하지 않다. (중초에 온열이 울증되어 발생)
6. 야열조량 (夜熱早凉)	• 밤에 발열하고 새벽에 열이 내림 은은한 반진, 출혈, 신훈섬어 증상
7. 경열 (驚熱)	• 밤에 열이 심함 몸에 열. 표증은 X (경풍+객으로 인해 발생)
8. 실열 (實熱)	• 1) 육음(六淫)에 외감되었거나, • 2) 음식내상으로 적체화열(積滯化熱)하여 발생
9. 소아허열 (小兒虛熱)	• 1) 땀을 많이 흘려 진혈 고갈→ 온열(溫熱), 조열(潮熱) • 2) 큰 병을 앓은 후에 원기를 손상 → 피로, 무력, 얼굴창백, 수족궤냉
10. 골증열 (骨蒸熱)	• 음식이 적체되었거나 큰 병을 앓은 후 여독(餘毒)으로 인해 발생 • 신체 수척, 해 질 무렵 조열, 도한심번, 복부 벽괴(癖塊)
11. 적열 (積熱)	• 열이 속에 쌓여 있는 증. 표리에 모두 열, 오래 지속, 땀이 붉고 입이 마름, 대소변 시원X
12. 태열 (胎熱)	• 모태에 있을 때 열사(熱邪)를 감수해서 발생

3) 오장열

분류	증상	치방	
		허	실
(1) 간열	근육뒤틀림(便難轉筋), 화내고 잘 놀람(多怒多驚), 사지곤권(四肢困倦)	신기환	사청환

(2) 심열	혈맥에 열(熱在血脈), 소변 붉고(小便赤腫), 소변 뚝뚝 떨어짐(淋瀝不通)	안신환	도적산
(3) 비열	잠만 자려함(怠惰嗜臥), 비린내 나는 토와 설사(吐腥泄瀉), 눈뜨고 잠(多睡露睛), 目黃	전씨백출산	사황산
(4) 폐열	피부에 열(熱在皮膚), 기침하고 코 건조(咳嗽鼻乾), 입술 창백·숨이 참(唇色白少氣喘)	량격산	사백산
(5) 신열	허열·발바닥 뜨거움(虛熱身重足熱), 눈동자가 아래로(下竄畏明)	지황환, 자신훈	

5. 치료

• 원인을 찾아 제거시키는 것이 무조건 열을 내리는 것보다 우선이며, 건강한 소아에서는 39도 미만의 발열은 대개 치료를 필요로 하지 않는다. 하지만 쇼크 대사 증가로 악화되는 기저질환, 혈량 혹은 전해질 부균형, 40도 이상의 고열, 아이가 불편해 할 때에는 해열제를 사용해야 한다. 한편 해열제는 열성 경련을 예방하는 효과가 없어 열성 경련 예방의 목적으로 사용하지는 않는다.

- 해열제로는 아세트아미노펜, 이부프로펜, 아스피린이 있으며 효과는 비슷하나 아스피린은 Reye 증후군과의 관련 때문에 소아 청소년에게는 권장하지 않는다. 아세트아미노펜은 기저질환이 없는 경우 선택하나 장기간 사용 시 신장 기능장애, 대량 복용 시 간 기능장애가 올 수 있다. 이부프로펜은 항염증 작용이 필요한 경우 선택하나 소화불량, 위장 출혈, 신장 혈류 감소를 유발할 수 있으며 드물게 무균성 수막염, 간독성, 재생불량성 빈혈 등을 일으킬 수 있다.

- 안정과 충분한 수분 공급이 중요하고, 미지근한 물을 적신 스펀지로 몸을 닦는 것은 아이가 고통스러워 우는 것에 비해 해열 효과가 크지 않아 하지 않는 것이 좋다

제 2 절 두통

0. 개요

- 국제 두통 진단 기준에서는 두통을 일차성 두통, 이차성 두통, 두부 신경통 및 안면 통증으로 분류하고 있으며 일차 두통이 약 90%를 차지한다
- 이때까지 두풍과 두통을 혼용하여 왔다.

1. 두통의 분류

- 일차성 두통(90%) / 이차성 두통 / 두부 신경통 및 안면통증

1) 일차성 두통

- 편두통이 소아 연령에서 가장 흔한 일차성 두통 원인 (사춘기 이전 남아↑, 사춘기 이후 여아↑)
- 통증 크기 : 삼차-자율신경계 두통 > 편두통 > 긴장성 두통

	편두통	긴장성 두통	삼차-자율신경계 두통
위치	• 소아는 대개 양측 • 전두부 호발 • 청소년은 60~70%가 일측 30%는 이마 혹은 전체	• 양측 • 전두부, 측두부, 교근, 익상근 흉쇄유돌근, 사각근, 승모근 압통	• 항상 일측, 안구 혹은 측두에서 시작
특징	• 점차적 시작해 심해지는 양상 • 박동성 • 중등도 혹은 중증의 강도 • 일상 신체 활동으로 악화 • 휴식, 수면 후 호전 • 발작성 두통이 반복하여 생김	• 심하다 멀해지는 압력 혹은 긴장 • 비박동성 (누르거나 조이는 양상) • 경도, 중등도의 강도 • 일상생활로 악화되지 않음 발작 시 안화됨	• 통증이 빠르게 시작 • 수 분 내 심해짐 • 깊고 지속적이며 대단하고 폭발적인 통증

		• 휴식, 수면 후 호전	
환아	• 어둡고 조용한 방에서 쉬는 것을 선호	• 활발하게 있을 수도 있고 휴식이 필요할 수도 있음	• 활발하게 있음
기간	• 2-72시간	• 다양	• 30분-3시간 (군발성)
관련 증상	• 오심, 구토 O • 빛 공포증, 소리공포증 O • 전조증상(대개 시각)	• 오심, 구토 X • 빛, 소리 공포증 X • 피로, 감정불안 동반	• 동측 눈물분비 및 안충혈 • 코막힘, 콧물, 창백, 발한 • 호너증후군 • 알콜에 민감

* 편두통

- 무조전조 편두통과 전조 편두통으로 분류하는데,
- 무전조 편두통은 편두통의 60~85%를 차지하며, 전조증상이 없고 아래 3가지 항목을 만족시키는 두통이 5번 이상 발작될 때 진단된다
- 1. 2~72시간 지속되는 두통 2. 편측이고 중등도 또는 심한 정도의 통증이며,

* 전조 편두통

- 편두통의 14~30%를 차지하며 다음 2가지 항목을 만족시키는 두통이 2회 이상 발작할 EO 진단된다.
- 1. 시각 전조, 감각 전조, 발화/언어 전조, 운동 전조, 뇌간 전조, 망막 전조 중 하나 이상의 전조 증상이 있고
- 2. 5분 넘게 서서히 퍼지는 전조 증상, 2개 이상 전조가 연이어 발생, 5~60분간 지속되는 전조, 일측 전조 양성전조, 전조 후 60분 내 두통 중에서 3가지 이상의 특징이 있는 두통. 지그재그 모양, 밖으로 볼록하게 각진 섬광, 암점 등의 시각 전조가 90% 이상으로 가장 흔하다.

* 긴장성 두통

- 긴장성 두통은 하루 중 오후에서 서서히 발생하며 신경학적 이상은 없고 피로 감정불안이 동반되며 스트레스 우울증과 연관이 많다. 잠을 자거나 휴식을 취하면 회복이 된다
- 긴장성 두통은 1. 30분~7일 간 지속되는 삽화두통 혹은 며칠간 지속적인 만성두통
- 양측 두통, 누르거나 조이는 양상, 경도 또는 중등도 두통, 일상 생활로 악화되지 않는 두통 중 2가지 이상의 특징이 있으며 오심/구토가 없고 빛공포증이 있다

2) 이차성 두통 : 질환에 의해 2차적으로 생기는 두통

① 두경부 외상	: 두부 외상, 편타 손상, 수술
② 두경부 혈관질환	: 뇌허혈, 동맥염, 혈관기형, 비외상성 두개내 출혈, 두개내 동맥질환 등
③ 비혈관 질환	: 뇌척수액 압력 증가or저하, 비감염성 염증질환, 두개내 신생물, 경막내출혈, 간질발작, Chiari 기형
④ 중독·금단증상	: 약제 남용
⑤ 감염	: 두개내 감염, 전신 감염
⑥ 항상성 이상	: 저산소증/고탄산혈증, 투석, 동맥성 고혈압, 갑상선기능저하증, 금식, 심장성 두통
⑦ 구조물 질환	: 두개골 질환, 경부 질환, 안질환, 이질환, 비부비동질환, 치아질환, 측두하악장애 등
⑧ 정신 장애	: 신체형 장애, 정신병

3) 두부 신경통 및 안면통증

두통 환자에서 신경계 영상 진단의 적응증

① 비정상적 신경학적 징후 혹은 간질
② 최근 발생한 중증의 두통
③ 두통 유형 변화
④ 뇌수막염, 뇌염, 두개내로 번지는 부비동염이 의심될 경우
⑤ 두개내 질환으로 발전하기 쉬운 기저질환을 가진 소아의 중증 두통 : 면역결핍, 겸상적혈구병, 신경 섬유종증, 신생물, 응고병, 고혈압

2. 변증시지

변증	증상	치법	처방
1) 풍한두통	풍한에 노출되면 심해짐 통증이 뒷덜미와 등으로 이어짐 구갈X 외감풍한 증상 코막히고 콧물(鼻塞流涕) 曰 : 풍한두통의 감별법 1. 풍한에 노출되었다 2. 통증이 뒷덜미와 등으로 이어짐	소산풍한	천궁다조산, 향갈탕 궁지향소산
2) 풍열두통 기출 ★	- 두통이 시작되면 앞이 캄캄해진다 - 창통이 극렬하다 - 열한 곳에서 심해지고 서늘해지면 완화된다 曰 : 풍열두통의 감별법 1. 열한 곳에서는 심해지고 서늘하면 완화된다 2. 창통이 극렬하다	소풍설열	궁지석고탕, 상국음 청상사화탕, 소풍산
3) 풍습두통 기출 ★	- 몸이 무겁게 느껴져서 움직이거나 머리를 들고 싶지 않다 - 무른 변을 본다 - 흐리거나 비오는 날에 심해짐 曰 : 풍습두통의 감별법 1. 흐리거나 비오는 날에 심해진다 2. 몸이 무거워, 움직이고 싶지 않다	거풍습습	강활습습탕, 이향산
4) 간양두통	두통, 두훈 번조이노, 야매불안 얼굴 붉고 입이 씹 曰 : 풍한두통의 감별법 1. 밤에 불안하다	평간잠양	천마구등음
5) 기허두통	힘든 일을 하면 심해짐 심하지 않은 두통이 계속됨 신피핍력 젖을 먹으려 하지 않음 추워하고 호흡이 짧음(段寒氣短) 曰 : 풍한두통의 감별법 1. 힘든 일을 하면 심해짐	보기화중 승제익기	순기화중탕
6) 혈허두통 기출 ★	- 가슴이 두근거리고 움직이면 심해진다 - 얼굴이 푸석하고 윤기가 없다 - 눈이 침침하고 아른거린다 - 가끔 어지러움이 있다 曰 : 혈허두통의 감별법	양혈위주	사물탕, 당귀보혈탕 건비이사탕

	1. 가슴이 두근거리고 움직이면 심해진다 2. 얼굴이 푸석하고 윤기가 없다			
7) 담탁두통 기출 ★	- 두통이 시작되면 앞이 캄캄해진다 - 묶은 가래를 토한다 - 머리가 어지럽다 (昏憒) 曰 : 담탁두통 감별법 1. 묶은 가래를 토한다		익기건비 조습화탁	이진탕, 반하백출 천마탕
8) 어혈두통	두통이 오래 지속 통증이 심박동과 관련 찌르는 듯 이 아픈 양상 통처가 바뀌지 않음 실질자암 맥삽 曰 : 어혈두통의 감별법 1. 자통과 통처가 바뀌지 않음		활혈화어	통규활혈탕
9) 신허두통	두통이오래됨 궁뜨고아둔해짐(智力遲鈍) 요슬산연 이명,수면장애(少寐) 曰 : 신허두통의 감별법 1. 두통이 굉장히 오래됨		자음보신	대보원전
10) 편두통	우측	담(痰), 열(熱)과 관계	-	이진탕
	좌측	풍(風), 혈허(血虛)에 기인		이진탕 습 사물탕
	칠정			청상견통탕
	미릉골통			가미선기탕

제 3 절 현훈

■ 현훈의 분류

1) 원인에 따라

		말초성	중추성
안진	방향	일측성, 빠른 방향은 정상 귀 방향 역방향 불가	환아가 느린 방향으로 볼 때 간혹 역방향
	유형	회선을 동반한 수평 순수한 회선이나 수직은 불능	어느 방향이든 가능
	시각고정	억제	억제되지 않음
신경학적 징후		없음	종종 있음
자세 불안정		일측 불안정, 보행 가능	중증 불안정, 보행 시 낙상
난청 혹은 이명		동반될 수 있음	없음

*시각고정 : 중추성의 경우 시각을 고정해도 현훈이 억제되지 않는다는 의미

2) 증상 별

현훈 (Vertigo)	① 운동감을 동반한 평형장애 → 전정신경계 장애가 원인 ② 환자 자신이나 주위의 물체가 돌거나 움직이는 기분(환각에 따른 회전성 움직임)
현기 (Dizziness)	① 일반적으로 모든 어지러움 을 총칭 ② 부적절한 감각상태(어찢어찢함, 졸도, 돌아가는 느낌) + 이상 감각(두통, 흐릿함)
불균형	① 신체 평형감각 실조 로 중심을 잡지 못함 → 소뇌, 척수, 말초신경장애가 원인 ② 실제로는 어지러움이 없으면서 어지럽다고 표현함
실신	① 뇌허혈 상태 시 발생 → 기립성 저혈압, 부정맥, 미주신경 실조 등이 원인 ② 일반적으로 현기의 범위에 포함

3) 지속시간 별

지속 시간	특징
수 초 ~ 1분 이내	양성 발작성 체위성 현훈
수 분 ~ 1시간	일과성 뇌허혈 발작, 편두통, 공황발작
수 시간 이상	메니에르 증후군
수 일 이상	전정신경병증
수 주 이상	다발성 경화증

4) 회전성 유무

회전성 현훈	주로 말초장애에서 관찰 - 난청 동반 시 : 돌발성 난청, 메니에르병, 청신경초종 등이 원인 - 난청 미동반 시 : 양성 발작성 체위성 현훈, 전정신경염, 내이혈관장애 등
비회전성 현훈	중추장애에서 관찰 - 뇌간 혹은 소뇌 종양, 추골뇌저동맥부전증 등

5) 변증시치

변증	증상	치법	처방
1) 풍열현훈	-어지럼증이 있음 / 머리가 아픔 / 발열 / 구갈 / 가래가 끈끈함 / 코가 막힘 / 얼굴이나 눈이 발적 / 변비 曰 : 풍열현훈의 감별법 1. 열증 (얼굴이나 눈이 발적, 구갈, 발열)	청설풍열	산국음
2) 풍한현훈	근육통 / 어지럼증 / 땀이 안나면서 오한이 있다 曰 : 풍한현훈의 감별법 1. 한증(땀이 안나면서 오한이 있다)	소산풍한	신출산, 삼오칠산
3) 풍습현훈	어지럼증이 있음 / 지체가 산연하다 / 머리가 무거워서 싸맨 것 같음 / 식욕부진 / 가슴이 답답하다 曰 : 풍습현훈의 감별법	거풍승습	국출산 강활승습탕

	1. 머리가 무거워서 싸맨 것 같다		
4) 신정부족	어지럽고 / 건망증이 나타난다 / 발육이 느리다 / 잠을 잘 못잔다. 曰 : 신정부족의 감별법 1. 건망증이 나타난다	자보간신	기국지황환
5) 기혈양허	눈 앞에 별 같이 반짝거리는 느낌이 있다 / 어지럼증 / 손톱 얼굴이 화색 없음 / 모발이 윤택하지 않음 曰 : 풍한두통의 감별법 1. 힘든 일을 하면 심해짐	보익기혈 건비안신	보종익기탕 합 인 삼귀비탕
6) 간양상항	- 어지럼증 / 머리 속이 터질 것 같음 / 화가 남 / 마음이 편치 않음 曰 : 간양상항의 감별법 1. 화가 나는 등 맘이 편치 않음	평간식품 자음잠양	사물탕, 당귀보혈탕 건비이사탕
7) 담탁중저 기출 ★	- 어지럼증 / 머리를 무언가로 싸맨 것 같이 무거움 / 조금만 움직이면 속이 메스꺼워 구토함 / 이명이 있음 / 가슴이 두근거림 / 식욕이 없음 曰 : 담탁중저 감별법 1. 머리가 무겁고, 조금만 움직이면 구토를 함	건비조습 거담식품	반하백출천마탕
8) 어혈폐규	어지럼증 / 밤이 되면 심해짐 / 혀가 암자색, 어반이 보임 曰 : 어혈두통의 감별법 1. 밤이 되면 심해짐, 혀가 암자색	거어통락 조기양혈	통규활혈탕

제 4 절 혈증

1. 철결핍 빈혈

1) 증상

- ① 혈색소치 6-10g/dl 정도가 되면 피부, 점막이 약간 창백해 보임
- ② 빈혈이 심해지면 : 현훈, 이명, 빈맥, 식욕부진, 감염이 잘 일어남, 주위에 대한 관심도↓, 기운이 없고 활동 감소, 이미증(異味症, 이식증)
- ③ 상당히 진행되면 : 설염, 입술증(입술 양 옆 갈라짐), 스폰형 손톱, 연하장애, 성장장애

2) 변증시치

철결핍 빈혈은 감염을 잘 걸리고, 스폰형 손톱, 입술이 양 옆으로 갈라졌다라고 제시 됩니다.

변증	증상	치법	처방
(1) 기혈양허	면색홍윤 혹 담백 입술 점막과 손톱이 약간 창백 설질담홍 태박백 맥허무력 日 : 기혈양허의 감별법 1. 면색이 홍윤하다	익기양혈(益氣養血) 건비조운(健脾助運)	팔진탕
(2) 비위허약	면색무화 혹 광백 손톱 혈색 없음 식욕부진, 사지권태, 무력 대변 묽음 순설색담 태박백 맥약 日 : 비위허약의 감별법 1. 면색이 밝지 않다(면색무화)	건비양혈(健脾養血) 운화정미(運化精微)	삼령백출산
(3) 심비양허 기출 ★	면색위황 구순·피부점막·손톱 창백 모발이 성글고 말라빠짐 심계기단 허번소매(虛煩少寐) 두훈목현, 정신위미, 주의력·기억력 ↓ 설질담 태박백 맥삭세약 日 : 심비양허의 감별법 1. 면색이 위황하다	보익심비(補益心脾) 자양기혈(滋養氣血)	귀비탕

(4) 비신양허	면색백 피부점막·손톱 창백 권태무력, 심계기단 사지불온, 밥 생각X 헛배부름, 소화 안됨 생장 발육지연, 피하지방감소 설질반논 맥침세 日 : 비신양허의 감별법 1. 면색이 하얗다	온보비신(溫補脾腎) 양혈전정(養血填精)	좌귀환
----------	--	--------------------------	-----

3) 빈혈 진단 기준 (정상 하한치)

나이	헤모글로빈(g/dl)	Hematocrit(%)
3-6개월	9.5	29
6-24개월	10.5	33
2-6년	11.5	34
6-12년	11.5	35
12-18세 (남)	13.0	37
12-18세 (여)	12.0	36

2. 특발 혈소판 감소 자색반병 (Idiopathic Thrombocytopenia Purpura, ITP)

1) 증상

- 갑자기 전신적인 점상출혈과 자반병이 '외상없이' 나타남
- 발병 초기 : 20,000/μL 이하의 혈소판 감소, 골수에 미숙한 거핵세포 증가, 혈소판항체 증가
- 혈소판 수가 10,000/μL 이하일 때 : 잇몸·점막 출혈, 코피, 성기출혈, 심하면 혈변·혈뇨·두개내출혈

2) 특징

- ① 자가면역 기전으로 발생
- ② 상기도 감염이 1-4주 전에 선행됨
- ③ 봄철에 발병률이 가장 높아서 연간 발생률의 1/3 차지
- ④ 2~8세 가장 많고, 9세 이후에는 드물며 성차는 없음. 예후는 성인에 비해 좋다

3) 변증시치

특발 혈소판 감소 자반증은 전신의 점상출혈(멍, 코피, 자반증) & 몇 주 전의 상기도 감염이 있다고 제시됩니다.

변증	증상	치법	처방
(1) 풍열상락	피하에 어짐, 잇몸출혈, 코피 미오한, 오통 전신 산통, 식욕부진 설질홍 태박황 맥부삭 曰 : 풍열상락의 감별법 1. 오한 오통이 있다.	거풍청열(祛風清熱) 량혈안락(涼血安絡)	은교산
(2) 혈열망행 기출 ★	- 자반이 선홍색이다 - 얼굴과 눈이 붉다 - 가슴이 답답하다 - 대변이 단단하다 曰 : 혈열망행의 감별법	청열해독(淸熱解毒) 량혈화반(涼血化斑)	청온패독산

	1. 자반이 선홍색		
(3) 기불섭혈 기출 ★	- 얼굴이 황색이다 - 자반이 담홍색이다 - 손톱이 백색이다 - 자주 피곤해하며, 식욕부진이 있다. 曰 : 기불섭혈의 감별법 1. 자주 피곤해한다 (기허)	보기섭혈(補氣攝血) 자양화원(滋養化源)	귀비탕
(4) 허화작락 기출 ★	- 손발이 뜨겁고, 가슴이 답답하고 밤에 열이 남 - 광대부위, 뺨이 붉음 - 전신에 점상출혈과 자반증이 있음 - 입이 마름 曰 : 허화작락의 감별법 1. 광대부위, 뺨이 붉음	자음강화(滋陰降火) 량혈지혈(涼血止血)	대보원전 합 천근산
(5) 비신양허	암적색 자반, 잇몸출혈, 코피 자반이 하지 위주 면색소화흑백, 형한지냉 어지럽고 두근거림 식사량 적음, 변이 묽음 설질 담홍 태박백 맥침혹세약 曰 : 비신양허의 감별법 1. 암적색 자반이 있다	온보비신, 익혈생수	석귀환